

# 保険診療のがん遺伝子パネル検査対象者

- 標準治療がない固形がん（希少がん、原発不明がんを含む）
- 局所進行もしくは転移があり、標準治療が終了した固形がん



## がんゲノム医療における がん遺伝子パネル検査

- 次世代シーケンサー(NGS)を用いてゲノム情報を解析するもので、2018年12月に承認され、2019年6月に保険収載された。
- がん遺伝子パネル検査では多数の遺伝子を一度に調べるため、正確に実施するには、高品質なDNAが十分量必要である。

# がんゲノム医療体制

- 検査工程
  - ✓ 次世代シーケンサー(NGS)を用いる
  - ✓ 外注委託
- エキスパートパネル
  - ✓ 中核拠点病院や拠点病院が主催
  - ✓ 検出された遺伝子異常に効果が期待できる治療薬があるかを検討
  - ✓ 二次的に見つかる遺伝性腫瘍の可能性についても議論

# 提示された治療薬への到達割合は高くない

| 試験                                 | 実施国       | 患者登録数<br>(検査可能) | 治療薬の<br>提示割合 | 薬剤到達割合       | 引用元                                                                                                                               |
|------------------------------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TOP-GEAR                           | 日本        | 187             | 58.2%        | 13.4%        | Sunami et al., Cancer Science, 2019.                                                                                              |
| 保険診療<br>(C-CATホームページ)              | 日本        | 30,822          | 44.5%        | 9.4%※        | <a href="https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/registration_status/">https://for-patients.c-cat.ncc.go.jp/registration_status/</a> |
| MSK-IMAPCT                         | 米国        | 5,009           | 75.7%        | 10.5%        | Zehir et al., Nature Medicine, 2017.                                                                                              |
| <b>杏林大学病院</b><br>(2021年7月~2023年6月) | <b>日本</b> | <b>252</b>      | <b>53.6%</b> | <b>13.1%</b> |                                                                                                                                   |

※エキスパートパネルで提示された治療薬が投与された割合

10~20%程度

臨床試験や治験の実施施設までの通院が120分を超えると、遺伝子異常に基づいた試験への参加率が低下するという報告あり。